Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 13ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 3181-0308

Processo nº 0021798-48.2021.8.17.2001

AUTOR(A): AMANDA DANTAS RANGEL CURSINO

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

AMANDA DANTAS RANGEL CURSINO ajuizou ação em face de **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,** buscando a condenação da ré a: (i) custear o tratamento com a medicação clexane 40mg, de uso diário, até o 42° dia após o parto, conforme prescrito pela médica assistente; (ii) autorizar quaisquer medicamentos que vierem a ser prescritos com a finalidade de evitar o abortamento da gestação; (iii) pagar-lhe indenizações (iii.a) por danos materiais, no valor de R$1.881,50 (um mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos); e (iii.b) por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Afirma, em síntese, que:

a) é beneficiária de contrato de assistência à saúde com cobertura hospitalar, ambulatorial e obstetrícia, administrado pela demandada, estando com suas obrigações contratuais pontualmente adimplidas (carteira n.° 88888464268230029);

b) tem histórico de abortos de repetição (duas perdas gestacionais), e foi diagnosticada como portadora de MTHFR em homozigose no gene C677T, patologia que acarreta risco de trombose e perdas fetais;

c) engravidou em 2018 e, ante o diagnóstico da patologia, os médicos assistentes prescreveram-lhe tratamento com a medicação Clexane 40mg, da qual fez uso durante toda a gestação e até 45 dias após o parto, com a finalidade de evitar trombose e nova perda gestacional;

d) naquela ocasião, requereu à ré a autorização do tratamento e custeio da medicação, porém, ante resposta negativa, necessitou propor ação judicial, que tramitou na Seção B da 29ª Vara Cível da Capital, sob o n.° 0006541-85.2018.8.17.2001;

e) está novamente grávida, na sétima semana de gestação, e os médicos especialistas que a acompanham prescreveram o uso da medicação clexane 40mg, durante toda a gestação e até 42 dias após o parto, a fim de evitar nova perda gestacional;

f) o tratamento foi mais uma vez negado pela operadora de saúde em contato telefônico, no dia 09.03.2021, às 15h20, sob a alegação de inexistência de previsão contratual de cobertura;

g) em função da urgência de seu tratamento, passou a obter a medicação por conta própria, adquirindo, até o momento, 10 (dez) doses da medicação Clexane 40mg, ao custo de R$1.881,50 (um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), quantia que requer seja reembolsada pela parte ré.

Juntou documentos e adiantou as custas e despesas processuais, nos valores de R$277,98 e R$181,94, em 6.4.2021 e 11.8.2021, respectivamente (Sicajud).

Pediu, em sede de tutela provisória de urgência, determinação deste Juízo para compelir a ré a autorizar o tratamento prescrito pelos médicos assistentes, fornecendo-lhe a medicação clexane 40mg, de uso diário, até o 42° dia após o parto, o que foi deferido (ID 77955514).

Nos termos da petição de ID 78436167, emendou a exordial, regularizando o valor da causa e esclarecendo que seu pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$1.881,50 (um mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), compreende o custeio de 44 (quarenta e quatro) doses da medicação Clexane 40mg, adquiridas por ela antes da propositura desta ação.

Em seguida, informou o descumprimento da obrigação pela ré (ID 78794458), acostando documento comprobatório (ID 78794461). Juntou ainda cupom fiscal de comprovação por ter adquirido mais 18 doses da medicação Clexane, ao custo de R$823,26, informando que garantiriam o tratamento da autora até o dia 30.04.2021 (ID 78794460) e aditou novamente a petição inicial, desta feita para incluir nos danos materiais a indenizar a nova quantia despendida, passando o valor total para R$2.704,76 (dois mil, setecentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

Ao tempo em que o Juízo recebeu a emenda à inicial (ID 78931425) consignou: (i) que o prazo de 48h fixado na decisão provisória para cumprimento da obrigação de fazer considerara as informações constantes nos autos à época; (ii) considerando o prazo fixado, e a data de intimação da ré (05.04.2021), o descumprimento teria início em 07.04.2021; (iii) muito embora tenha havido escoamento do prazo para cumprimento, sem que tenha havido o fornecimento da medicação, o reconhecimento de astreintes desde o dia 07, resultaria em compelir a parte ré a pagar em duplicidade pela mesma obrigação, isto é, ressarcir as doses adquiridas pela autora

antes da propositura desta ação, que contemplariam o seu tratamento até o dia 09.04.2021 e, ao mesmo tempo, incorrer em multa por não fornecer as doses, conquanto já adquiridas pela parte; (iv) que a autora teria ficado sem tratamento do dia 10.04.2021 até 14.04.2021, porém, entendeu por necessário ouvir a parte ré antes de reconhecer a multa por descumprimento.

A operadora de Saúde interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar, ao qual foi negado provimento (ID 112526466).

Em sede de contestação (ID 79282252), alega a operadora demandada, em suma, que: a)inexiste obrigação legal (rol ANS) e contratual para custeio do medicamento CLEXANE; e b)agiu no exercício regular de direito, inexistindo danos morais a indenizar. Juntou documentos.

Em 30.04.2021, a parte autora se manifestou (ID 79706356), aduzindo que a medicação passou a ser fornecida a partir do dia 15.04.2021 e requereu mais uma vez o reconhecimento do descumprimento da tutela provisória do dia 07.04.2021 ao dia 15.04.2021.

Por meio da petição de ID 81269402, a parte ré veio aos autos esclarecer que, quando se trata de ordem de fornecimento de medicamentos, possui logística que leva de 3 a, no máximo, 7 dias para entregar a medicação na casa do cliente. Na sequência, propôs reembolsar a cliente pelas medicações adquiridas, ou efetuar depósito judicial do valor da primeira caixa adquirida.

Na sequencia, a parte ré comunicou o cumprimento da liminar, e juntou comprovante (ID 81795843).

Em petição protocolada no dia 22.07.2021 (ID 84576459), a parte autora comunicou a alteração da dosagem diária da medicação prescrita, e requereu a modificação da tutela provisória, para que a ré fosse compelida a fornecer a medicação conforme a nova prescrição.

Por meio da decisão de ID 84638308, este Juízo: a) reconheceu que houve descumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de urgência no período de 10.04.2021 a 14.04.2021, incidindo astreintes à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais); b) modificou a tutela provisória de urgência para que a parte ré passasse a fornecer a medicação Clexane 60mg, para uso diário, até o 42° dia após o parto, conforme nova solicitação médica (ID 84577885). Fixou o prazo de 7 (sete) dias para a entrega das ampolas referentes ao próximo ciclo de tratamento, com doses atualizadas (60mg), sob pena de multa de R$1.000,00, por dia de tratamento que a parte autora deixar de realizar na dose correta por responsabilidade da operadora.

Alegando novamente o descumprimento da tutela provisória de urgência (IDs 85397307 e 85620987), a parte autora aduziu que, para garantir o tratamento até o dia 03.08.2021 (ID 85397307), precisou adquirir mais 04

doses de Clexane 40mg e 06 doses de Versa 60mg (medicamento com o mesmo princípio ativo do Clexane, qual seja enoxaparina sódica), em razão do que suportou despesa de R$833,44 (oitocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos – ID 85397309). Asseverou ainda que, em face da continuidade do descumprimento, para manter o tratamento até o dia 09.08.2021 (ID 85620987), adquiriu mais 06 doses de Clexane 60mg, gastando R$480,88 (quatrocentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos – IDs 85620982 e 85620986).

Por meio da decisão de ID 85679015, alterando a forma de cumprimento da tutela provisória de urgência, este Juízo determinou que a ré depositasse na conta corrente da parte autora, de forma adiantada, o valor necessário para garantir o tratamento a cada trimestre, sob pena de constrição judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015. Determinou a intimação da ré para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar-se sobre as petições de IDs 85397307 e 85620987, e comprovar o cumprimento da tutela provisória no que se refere ao fornecimento das doses até o dia 09.08.2021, e, em caso negativo, efetuar o depósito judicial do valor concernente ao ressarcimento pela compra da medicação prescrita (Clexane e Versa - enoxaparina sódica) no valor total de R$1.314,32 (IDs 85397309, 85620982 e 85620986), sob pena de constrição judicial via Sisbajud (art. 139,IV, do CPC/2015).

Conquanto intimada em 12.8.2021, às 14h24 (IDs 86097800 e 86097802), a parte ré deixou de comprovar o cumprimento da tutela provisória no que se refere ao fornecimento das doses de Clexane/Versa até o dia 9.8.2021 ou de efetuar o depósito judicial do valor concernente ao ressarcimento pela compra da medicação prescrita (Clexane e Versa - enoxaparina sódica) no valor total de R$1.314,32 (IDs 85397309, 85620982 e 85620986), razão pela qual este Juízo determinou a constrição judicial via Sisbajud, revogando a determinação de depósito trimestral contida na decisão de ID 85679015.

Determinou-se, ainda, a intimação da autora para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar os dias de tratamento que deixou de realizar na dose correta por responsabilidade da operadora, para fins de fixação de período de descumprimento da decisão de ID 84638308. Ressaltou que, conforme esclarecido em decisão de ID 84638308, a multa foi fixada para cada **dia de tratamento** em que a autora não recebeu a dose correta **e não a cada dia de demora no fornecimento da medicação.**

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela autora, este juízo esclareceu que a fixação do período de eventual descumprimento da decisão antecipatória de ID 84638308 seria analisado em momento oportuno, posto que, na decisão embargada, ainda havia a determinação de intimação da parte contrária para apresentar manifestação. Outrossim, sequer constavam dos autos elementos suficientes para fixação do período, conforme determinação contida no item 3 do decisum. No que diz respeito à fixação

de multa para eventual descumprimento da parte final da decisão de ID 85679015, entendeu este juízo que a pretensão perdera o objeto, porquanto modificada a forma de seu cumprimento nesta decisão.

Bloqueado o valor (ID 90401864), foi expedido alvará de transferência (ID 90468338).

Por meio da petição de ID 91961885, a promovente esclareceu que, "apesar da omissão no cumprimento da Ré, a Autora em momento algum deixou de realizar o tratamento correto prescrito pelo seu médico, nem poderia deixar de fazê-lo, sob pena de arriscar a sua própria vida. Não há possibilidade em que a Autora fosse permitir isso acontecer, ainda mais considerando que esteve em período gestacional." Ao final, pleiteou a reconsideração da decisão de ID 89777981 para: a) "Reconhecer e efetivamente condenar a Ré na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), pelos dias em que a Ré deixou de fornecer à Autora a medicação determinada pela decisão de ID nº 77955514, isto é, mesmo tendo sido intimada a fornecer em nova dosagem e não tendo fornecido medicação alguma, contados a partir do dia 01/08/2021 (quando intimada da nova dosagem) até a data de proferimento da decisão de ID nº 85679015, em 07/08/2021, configurando-se 07 (onze) dias de descumprimento ou 07 (sete) doses não fornecidas; e b) Reconhecer e condenar a Ré em astreintes pelo descumprimento do comando judicial da decisão de ID nº 85679015, no mesmo valor fixado nas decisões anteriores, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, contados da data em que a Ré deveria ter cumprido a decisão (16/08/2021) até a data em que determinado o bloqueio em 11/10/2021, configurando-se 56 (cinquenta e seis) dias de descumprimento, em que não foi realizado o depósito judicial dos valores orçados pela Autora.

O autor apresentou réplica à contestação (ID 86096367).

Intimadas, as partes não demonstraram interesse na produção de provas complementares (IDs 139763797 e 141994330).

É o que importa relatar. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do disposto no art.355, I, do CPC/2015, porquanto desnecessária a produção de outras provas. Destaque-se ainda que, conquanto intimadas para especificar as provas cuja produção tivessem interesse, as partes nada requereram.

Os laudos hematológico e obstétrico anexados aos autos (ID's 77742511, 77742507 e 77742508) consignam que a parte autora (i) é portadora de trombofilia e Mutação do Gene Metilenotetraidrofolato Redutase (MTHFR); (ii) tem histórico de abortamentos prévios e alteração de doppler em gestação anterior; (iii) tem indicação formal de uso de anticoagulante (Clexane 40mg) para profilaxia de aborto, trombose, pré-eclâmpsia e

prematuridade, durante toda a gravidez e até o 42° dia após o parto; (iv) quando da propositura do feito estava grávida, na sétima semana de gestação, havendo indicação de urgência no uso da medicação.

O contrato firmado entre as partes encerra relação de consumo, desafiando a aplicação da legislação consumerista, nos exatos termos do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).

Além disso, ao caso também deve ser aplicada a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

O art. 10 da referida lei preceitua que, *in verbis*:

> Art. 10. **É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar**, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, **das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde**, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
>
> I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
>
> II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;
>
> III - inseminação artificial;
>
> IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;
>
> V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
>
> VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;
>
> VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;
>
> VIII - revogado;
>
> IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
>
> X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.
>
> (...)

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o plano-referência deve assegurar cobertura a todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, ressalvadas as exclusões enumeradas nos incisos I a X.

No presente caso, segundo o laudo médico juntado aos autos, a autora era portadora de doenças que constam da lista da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e que, portanto, possuem cobertura pelo contrato de assistência à saúde firmado entre as partes.

A teor do que prescreve o inciso II do art. 35-C, da Lei 9.656/98 (LPS), "**complicações no processo gestacional**" caracterizam regime de urgência, **sendo obrigatória a cobertura de qualquer procedimento nesta situação.**

Considerando que as enfermidades que acometem a parte autora lhe causaram perdas fetais anteriores, tenho por incontroverso o quadro de complicação no processo gestacional, sendo obrigatório, pois, o seu tratamento.

Demais disso, não me impressiona o argumento de que o tratamento com a medicação clexane não consta do rol da ANS. Não pode a seguradora recusar-se a custear determinado tratamento/procedimento única e exclusivamente sob a alegação de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

Destaque-se que, ainda que se conclua, à vista do recente julgamento do STJ, no sentido de que o rol de procedimento e eventos em saúde emanado da ANS é taxativo, **aquele julgado ressalvou a cobertura de tratamento efetivamente imprescindível para a saúde do beneficiário, ainda que não previsto no rol de procedimentos.**

Ademais, ao longo da tramitação do presente feito, fora publicada a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Confira-se:

> Art.10. (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente **que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo**, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)
>
> **I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (grifei)

Outrossim, resta pacificado na jurisprudência do STJ que somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente, não estando a seguradora habilitada, nem tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor. Isso porque a seguradora não pode substituir-se aos médicos na opção terapêutica. Assim, se a patologia está prevista no contrato, não pode haver qualquer mitigação quanto ao procedimento recomendado pelo médico quando da avaliação do paciente e de sua patologia, por quem não detém técnica nem competência para fazê-lo.

Confira-se:

> "A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n ° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde. De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor. Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n ° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n ° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02). Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a

> utilização de esfíncter artificial para controle da micção. O mesmo se diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a cura da doença. Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor" (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 29/06/2007).

No mesmo sentido ainda STJ - Resp. 1.053.810-SP.

Ressalte-se ainda que, com o paulatino avanço da medicina, muitos protocolos vêm sendo simplificados, de modo que tratamentos que antes exigiam internação ou que eram realizados em clínicas, inclusive com risco de exposição do paciente a infecções as mais diversas, vêm sendo substituídos por injeções administradas pelo próprio paciente em ambiente domiciliar ou mesmo por medicação oral. É exatamente o caso dos autos.

Em casos tais, a negativa de fornecimento de fármaco para administração em ambiente domiciliar levaria à situação de inaceitável iniquidade em que o paciente haveria de permanecer em leito hospitalar ou mesmo dirigir-se a clínica, sob pena de lhe ser negada a cobertura, quando, na verdade, o tratamento se afigura mais eficaz se realizado independentemente de internação.

A propósito, colho julgado que trata de matéria semelhante à dos presentes autos:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A SER MINISTRADO EM AMBIENTE DOMICILIAR, E NÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. . AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos CDC do art. 47, do diploma consumerista, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em benefício do consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica, considerando a imposição unilateral das condições do contrato. Assim, devem ser declaradas suas ilegalidades e abusividades quando infringir direitos da parte hipossuficiente. 2.* ***Considerando a expressa cobertura contratual para obstetrícia, é ilegal a recusa de fornecimento do medicamento prescrito por profissional competente (Clexane 40 mg) para tratar a Trombofilia Hereditária que acomete a Agravante, sendo irrelevante a sua realização se dar em ambiente domiciliar.*** *3. Nos termos da jurisprudência do STJ: É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar. (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS*

FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013). 4. Agravo a que se dá provimento. (AI 3811496-PE, TJPE, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Roberto da Silva Maia, j. em 04.08.2015)

Retenha-se que o medicamento prescrito à autora está registrado perante a ANVISA, sob o n.º 183260336, em solução injetável, de uso subcutâneo ou intravenoso, conforme aferido no bulário eletrônico daquele órgão (https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=CLEXANE (https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=CLEXANE)).

Nesse contexto, tenho que a pretensão autoral para cobertura obrigatória do tratamento pela operadora ré merece guarida. Confirmo as decisões concessivas de tutelas provisórias de urgência deferidas nestes autos para garantia do tratamento prescrito à autora, com ressalvas em relação à aplicação das astreintes, que serão objeto de tratamento também nesta sentença.

A pretensão de reparação civil por danos morais também merece acolhida.

Malgrado, em regra de princípio, o mero inadimplemento contratual seja insuficiente à configuração de danos extrapatrimoniais, a jurisprudência vem reconhecendo que a indevida recusa a cobertura de contrato de assistência à saúde pode sim ensejar a configuração de dano moral indenizável (STJ: AREsp 946150/SP; AREsp 919439/RJ; AREsp 708894/DF; AgInt no AREsp 1022746/RN; AgRg no AREsp 666568/RJ).

É que, se de um lado é certo que, no mais das vezes, o não cumprimento de obrigação contratual impõe prejuízos de ordem unicamente material, de outro, importa ver que, em determinadas circunstâncias, o descumprimento do contrato pode exacerbar a seara patrimonial, dando causa a uma violação dos direitos da personalidade, ao comprometimento da honra, da dignidade ou da intimidade da pessoa humana, ou mesmo deflagrando ou agravando séria e compreensível situação de angústia, insegurança, aflição ou dor psíquica e/ou física de quem já se acha com a saúde debilitada, como ocorreu in casu. Nessas situações, do descumprimento do contrato decorrerá não só danos materiais, mas também morais, e, dado que a Constituição da República adotou o princípio da reparação integral (art. 5º, V e X), além de responder pelas perdas e danos materiais (art. 389 do CC), o responsável pelo inadimplemento deverá indenizar também os danos extrapatrimoniais.

Certamente, a recusa na autorização do tratamento médico solicitado pela autora e prescrito pela sua médica assistente, em razão do diagnóstico de trombofilia, é suficiente para agravar a angústia, a insegurança, a aflição e a dor psíquica da qual inexoravelmente já se achava acometida a paciente.

Em verdade, não há como deixar de reconhecer que a demandante, já extremamente desgastada física e emocionalmente, viu-se inesperadamente desamparada justamente por aquele que foi contratado e remunerado para ampará-la nessa circunstância.

Ora, quem se vincula a plano de saúde o faz em busca de segurança e confiança futura para os seus bens mais preciosos: a saúde e a vida. Assim, o descumprimento de contrato dessa natureza, ao frustrar tais expectativas, impingindo ao paciente a sensação de abandono, à toda evidência é capaz de causar-lhe profunda dor psíquica e sofrimento indenizável a título de dano moral.

À vista de tais considerações, tenho como configurados o dano moral e o dever de indenizar.

Fixo o valor da indenização.

A indenização em face do dano moral tem caráter reparatório e punitivo-pedagógico. De um lado, visa reparar, ainda que de forma paliativa, a angústia experimentada pelo lesado. De outro, objetiva impulsionar o ofensor a cercar-se de novos cuidados a fim de não mais incidir em condutas ilícitas da mesma natureza, vale dizer, visa impedir a repetição de fatos idênticos ou assemelhados.

De realçar ainda a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na fixação do quantum indenizatório de dano moral "[...] recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (Cfr. REsps. nºs. 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).

No caso dos autos, tenho que a empresa ré agiu com culpa grave, pois quando da negativa de autorização de cobertura de medicamento essencial para o tratamento da autora, tinha ciência de que a enfermidade que o acometia poderia resultar em dano grave à sua saúde e à sua gravidez. Inarredável a conclusão de que o descumprimento contratual foi voluntário e consciente, agindo a operadora com culpa grave.

Por outro lado, a ré é empresa de significativo porte financeiro. Indenização modesta em termos pecuniários certamente não a estimulará a revisar conceitos e comportamentos com o objetivo de não mais praticar a conduta ilícita. Ademais, indenizações módicas têm permitido que o fornecedor lucre com a ofensa moral, preferindo, aqui e ali, arcar com indenizações a aparelhar-se adequadamente segundo as exigências do mercado consumidor e as interpretações assentadas pelo Poder Judiciário.

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando sobretudo as peculiaridades do caso, já bem delineadas, para garantir à segurada a justa reparação pelos danos sofridos, sem que esta incorra em enriquecimento ilícito, e ainda atenta ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda, fixo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Da alegação de descumprimento das decisões concessivas da tutela provisória de urgência

Dos autos, verifico que, por inúmeras vezes, a operadora demandada deixou de cumprir os comandos judiciais, tendo ocorrido, inclusive, bloqueio judicial de valores para pagamento de parte do tratamento. Outrossim, por diversas vezes, a autora necessitou comprar a medicação de forma particular para garantir a continuidade de seu tratamento.

Não há como não se reconhecer a desídia em cumprir as decisões judiciais. Anoto que as alegações de demora de fornecimento das medicações pelas empresas que o comercializam não retira a obrigação da ré de garantir o tratamento, notadamente por ser de caráter de urgência.

Outrossim, nada impedia que a demandada realizasse o depósito judicial da totalidade do tratamento para que a autora pudesse realizar a compra de forma particular.

Posto isso, taaaa/aaomo por bem revogar a decisão de ID 78931425 no que toca ao seguinte ponto:

"Ressalto que a decisão liminar fixou prazo para fornecimento da medicação considerando as informações constantes nos autos à época. Entendo, no entanto, que a parte ré não poderá ser compelida a cumprir duas vezes a mesma obrigação, isto é, ressarcir o tratamento, adquirido antecipadamente pela autora, até o dia 09.04.2021 e, ao mesmo tempo, incorrer em multa por descumprimento a partir do dia 07.04.2021, porquanto o valor contido no pedido condenatório inicial inclui o fornecimento da medicação até o dia 09.04.2021."

Isso porque, o fato de a autora ter adquirido medicação de forma particular não exime a ré de dar cumprimento à determinação judicial. Anote-se que a determinação no sentido de que a demandada realize o reembolso e sofra a incidência de astreintes pelo atraso no fornecimento da medicação não configura bis in idem.

Posteriormente, à vista da necessidade da autora, foi **a tutela provisória de urgência ampliada e modificada** para que a parte ré passasse a fornecer a medicação **Clexane 60mg, para uso diário, até o 42° dia após o parto,** conforme nova solicitação médica (ID 84577885). Foi fixado prazo **de 7 (sete) dias** para a entrega das ampolas referentes ao próximo ciclo de

tratamento, com doses atualizadas (60mg), sob pena de multa de R$1.000,00, a cada dia de tratamento que a parte autora deixar de realizar na dose correta por responsabilidade da operadora.

Conforme solicitação da operadora, o prazo para cumprimento da tutela provisória foi fixado em razoáveis 07 dias, nos termos da decisão de ID 84638308, da qual foi a parte demandada intimada em 23.07.2021 (ID 84725733). Por meio da petição de ID 81269402, a parte demandada novamente sustentou que a burocracia relativa à compra e entrega da medicação impedia a observância do prazo fixado, ventilando a possibilidade de depósito judicial integral do valor necessário para que a autora adquira as doses. Ocorre que, instada a comprovar o cumprimento da medida, a ré quedou-se inerte, deixando, inclusive, de realizar o depósito judicial, razão pela qual foi determinado o bloqueio judicial de R$11.739,56, tendo o valor sido transferido para a autora.

Houve determinação de intimação da autora para especificar os dias de tratamento que deixou de realizar na dose correta por responsabilidade da operadora para fins de fixação de período de descumprimento da decisão de ID 84638308, com o esclarecimento de que na decisão de ID 84638308, a multa foi fixada para cada **dia de tratamento** em que a autora não recebeu a dose correta **e não a cada dia de demora no fornecimento da medicação**.

Ocorre que a autora esclareceu que não deixou de realizar o tratamento e que o custeou, em parte, de forma particular, notadamente em razão do risco de ter complicações na sua gravidez. Esclarece que, após a modificação da decisão antecipatória, a ré não forneceu a medicação.

Assim, tendo em vista (i) a desídia da ré em dar cumprimento às determinações judiciais, (ii) o valor total do tratamento perseguido nos autos e (ii) os inúmeros dias de descumprimento, que ensejariam considerável montante a título de multa, tomo por bem fixar, a título de astreintes, o valor total R$20.000,00, revogando as disposições contidas nas decisões constantes desses autos no que toca à fixação de multa e descumprimento.

Destaque-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, **é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo**, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante(AgInt no AREsp 2233172 / PR, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJE 21.6.2023).

À vista do exposto, extinguindo o processo com resolução de mérito, **julgo procedentes os pedidos** (art. 487, I do CPC/2015) e, confirmando os efeitos das tutelas provisória de urgência, com ressalva referente às multas por descumprimento, condeno a demandada a:

a)custear integralmente o tratamento prescrito pelos médicos assistentes com a medicação clexane, até 42 dias após o parto, realizando, inclusive, o reembolso dos gastos comprovados pela autora com a compra de parte das medicações (para a hipótese, devem incidir correção monetária- tabela Encoge e juros de mora de 1%, desde o desembolso), consoante notas fiscais anexadas aos autos;

b) pagar à demandante, a título de indenização por danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de correção monetária (índices da tabela do Encoge), a partir do presente arbitramento (súmula 362 do STJ), e de juros legais de mora (1% - um por cento ao mês - art. 406 do CC c/c art. 161, §1°, do CTN), a partir da data da citação (art. 405 do CC);

c) ressarcir à parte demandante os valores adiantados a título de custas e despesas processuais (R$277,98 e R$181,94), atualizados pela Tabela Encoge desde as datas dos pagamentos (6.4.2021 e 11.8.2021);

d) pagar ao(s) advogado(s) constituído(s) pela parte autora honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do proveito econômico obtido pela demandante, que corresponde à soma do valor da indenização por danos morais com o valor dos custos do tratamento perseguido, tudo com fulcro no art. 85, §2°, do CPC/2015 e no atual entendimento firmado pelo STJ[i] (file:///C:/Users/amand/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/clexane.docx#_edn1

e)pagar à autora, a título de astreintes, R$20.000,00 (vinte mil reais).

Opostos embargos de declaração com efeito modificativo, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. (art. 1.023, § 2°, do CPC/2015), e decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, recebo-o nos seus regulares efeitos e determino a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões (art. 1010, §1°, do CPC/2015). Havendo alegação – em sede de contrarrazões - de questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportaram agravo de instrumento, intime-se a parte adversa (recorrente) para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. 1.009, §§ 1° e 2°, do CPC/2015). Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se a parte apelante para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §2°, do CPC/2015). Em seguida, com ou sem resposta, sigam os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com os cumprimentos deste Juízo (art. 1010, §3°, do CPC/2015).

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, independentemente de nova determinação. Intimem-se.

Recife/PE, data da assinatura digital.
Mariana Vargas Cunha de Oliveira Lima
Juíza de Direito

[i] (file:///C:/Users/amand/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/clexane.docx#_ednref1) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.

2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

3. Embargos de divergência providos.

(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 198.124 - RS (2012/0136891-6)

Assinado eletronicamente por: MARIANA VARGAS CUNHA DE OLIVEIRA LIMA
15/12/2023 09:37:44
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 155579984

23121509374402100000151967434

IMPRIMIR GERAR PDF